

百度健康行业研究与战略分析

第一部分：行业与政策

1.1 研究边界：百度健康研究的是“平台层”，不是整个医疗体系

这次研究的第一件事，是先把行业边界定清楚。百度健康并不等同于传统医院、医药电商、保险公司或线下药房，它更像位于“流量入口—信息组织—患者服务—医生/医院连接”之间的中间层平台。如果把它当成线上医院，会误判它的资质边界；如果把它当成医药零售商，又会误判它与京东健康的竞争方式。

百度 2025 年 20-F 对百度健康的表述很明确：Baidu Health 通过 AI building blocks 帮助用户找到更适合其医疗需求的医生和医院，并通过百度健康医典、短视频、直播、远程医疗和托管管理工具，为医生和医院提供线上存在与患者管理能力，包括消息、预约、改期和治疗计划监测。^[S1] 这个表述决定了本文的分析起点：百度健康的核心不是“自营医疗交付”，而是“组织需求并连接供给”。

这也解释了为什么真实性原则在百度健康研究中比在大众汽车研究中更重要。大众汽车有完整的分品牌、分区域、交付量、收入、利润和现金流披露；百度健康没有独立财务披露。因此，本文能较强地分析“方向、定位、可行路径”，但不能伪造“百度健康独立收入和利润”。

1.2 行业空间：不是线上问诊的小赛道，而是医疗服务重构的大入口

中国数字健康的底层空间来自三个变量：第一是医疗支付体量，第二是医疗服务频次，第三是慢病与老龄化管理需求。国家卫健委披露，2024 年全国卫生总费用初步核算为 90895.5 亿元，占 GDP 比重 6.7%；全国医疗卫生机构总诊疗人次达到 101.5 亿；基层医疗卫生机构接受健康管理的 65 岁及以上老年人

为 14136.0 万人。

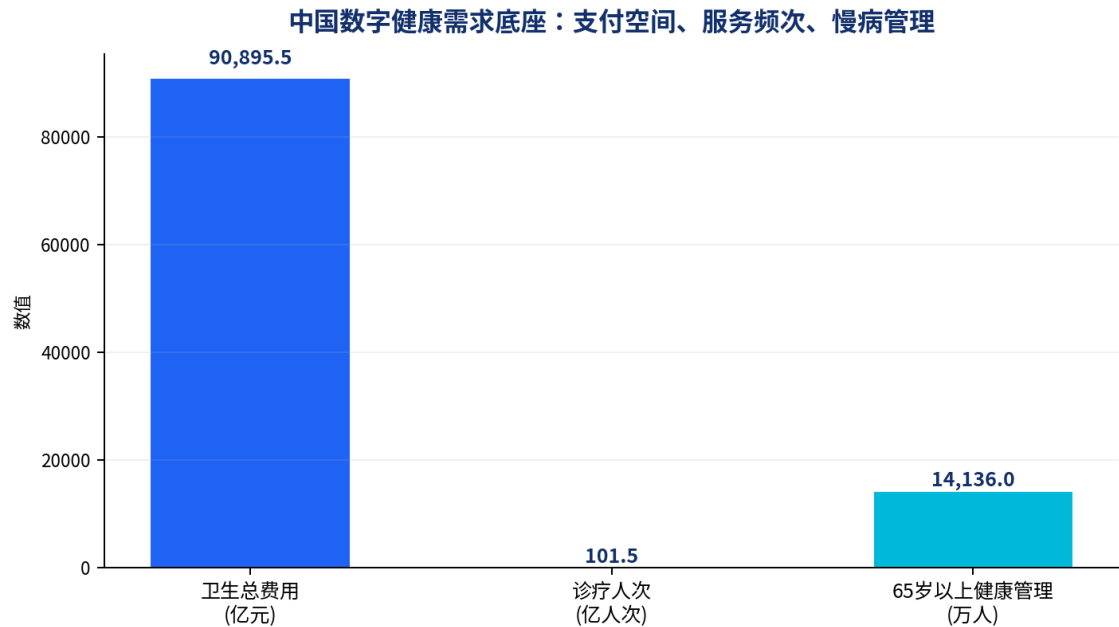


图 1：中国数字健康行业需求底座

资料来源：国家卫健委 2024 年卫生健康事业发展统计公报新闻解读稿

这三组数字对应的是百度健康的三类机会：卫生总费用代表支付空间，诊疗人次代表服务频次，老年健康管理代表慢病和连续服务场景。对百度来说，真正值得做的不是一次性健康流量，而是把用户在搜索端表达出的高意图健康需求，转成可跟踪、可连接、可复诊、可随访的服务链。

1.3 政策方向：AI 医疗的机会在“流程侧”，不是无边界诊断

国家卫健委等部门在《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》中提出，到 2027 年形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用，到 2030 年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。政策列出的重点应用不仅包括影像诊断和临床辅助决策，也明确包括慢病规范管理、个人健康画像、智能预问诊、精准预约分诊导诊、智能随访、智能转诊、移动支付、医保一站式结算和院后管理。^[53]

这对百度健康非常关键。它说明 AI 医疗不是只能在医院内部做“辅助诊断”，也可以在患者服务流程侧创造价值。百度的入口优势和 AI 能力，更适合承接诊前、诊中、诊后流程：搜索症状、理解风险、建议科室、连接医生/医院、提醒复诊、管理慢病。

1.4 监管边界：平台可以做连接和编排，但不能越界替代持牌医疗主体

医疗健康不是普通互联网内容品类。百度 20-F 的监管章节提到，互联网医院与互联网诊疗在中国需要依托实体医疗机构，互联网诊疗必须由持有《医疗机构执业许可证》的医疗机构提供，且涉及互联网医院的信息系统安全等级保护、医生电子注册、诊疗科目一致性等要求。^[54]这意味着百度健康的最佳模式不是变成独立诊疗主体，而是与持牌机构协同，做连接、流程、工具、内容和合规管理。

第二部分：商业模式与竞争

2.1 百度健康在百度体系中的位置：从搜索意图到服务管理

百度健康不是孤立业务，而是嵌在百度移动生态中的服务类垂直场景。百度 2025 年 20-F 披露，百度 App 是中国领先的 search-plus-feed 应用，2025 年 12 月 MAU 为 6.79 亿；百度 App 通过 AI building blocks 聚合第三方 App 和网站的内容与服务，并将流量导向第三方内容和服务提供者。百度还明确写到，用户互动和登录能力正在支持百度从在线营销扩展到更多服务变现，例如百度健康。[S1]

这意味着百度健康的上游不是单独获客，而是继承百度搜索和信息流中的健康意图流量。它的战略价值，是把“用户在百度问健康问题”延伸成“用户完成下一步健康行动”：找医生、找医院、理解病情、预约、复诊、随访和管理治疗计划。

2.2 百度健康的四类潜在收入池

收入池	商业逻辑与边界
健康场景流量变现	来自健康科普、医生/医院页面、直播、问答、内容生态和高意图线索，但必须严控广告与自然结果边界。
医生/医院数字化工具	页面托管、患者消息、预约改期、随访管理、内容运营、AI 客服和辅助文书等工具，可能更符合百度 AI 能力。
导流与平台服务分成	与持牌机构合作，把分诊、问诊、检查、体检、复诊、慢病管理做成服务入口。
远期 AI 健康助手/企业健康管理	在合规前提下做长期健康账户、慢病助手和企业员工健康管理，但需验证支付意愿。

本文刻意不把“自营药品销售”列为百度健康的核心能力。原因不是药品销售不重要，而是公开披露并未表明百度健康已经形成类似京东健康的供应链和履约护城河。真实性优先的写法，应当承认百度的优势在入口、AI 和连接，不在仓配、库存和药品零售。

2.3 竞争格局：百度健康与京东健康是“同赛道、不同物种”

中国数字健康竞争定位：百度应错位，不应复制京东

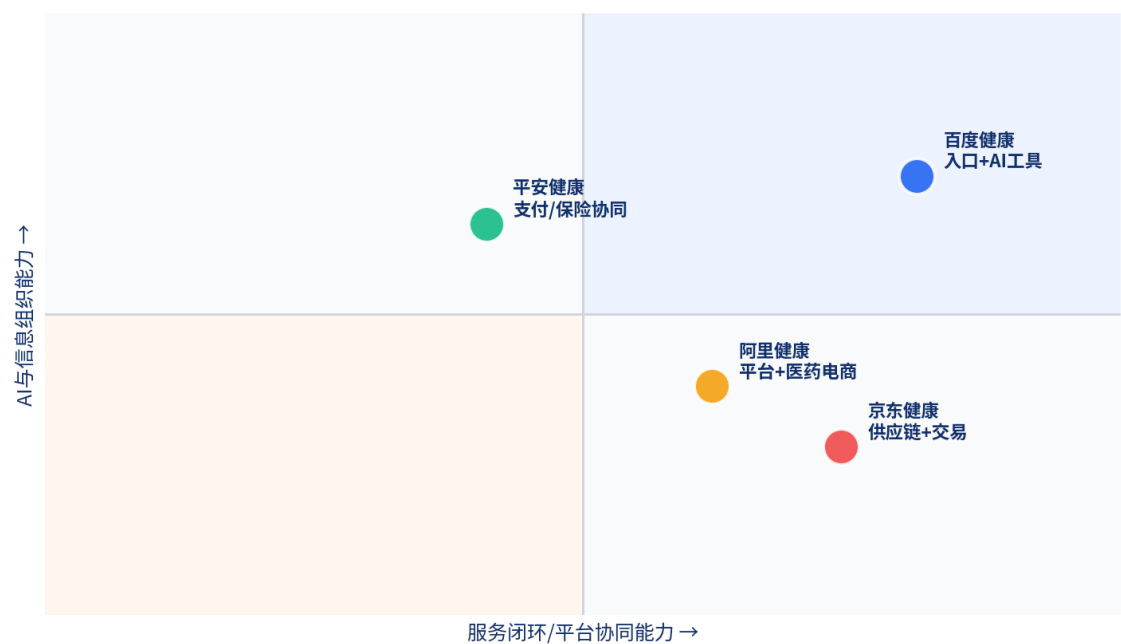
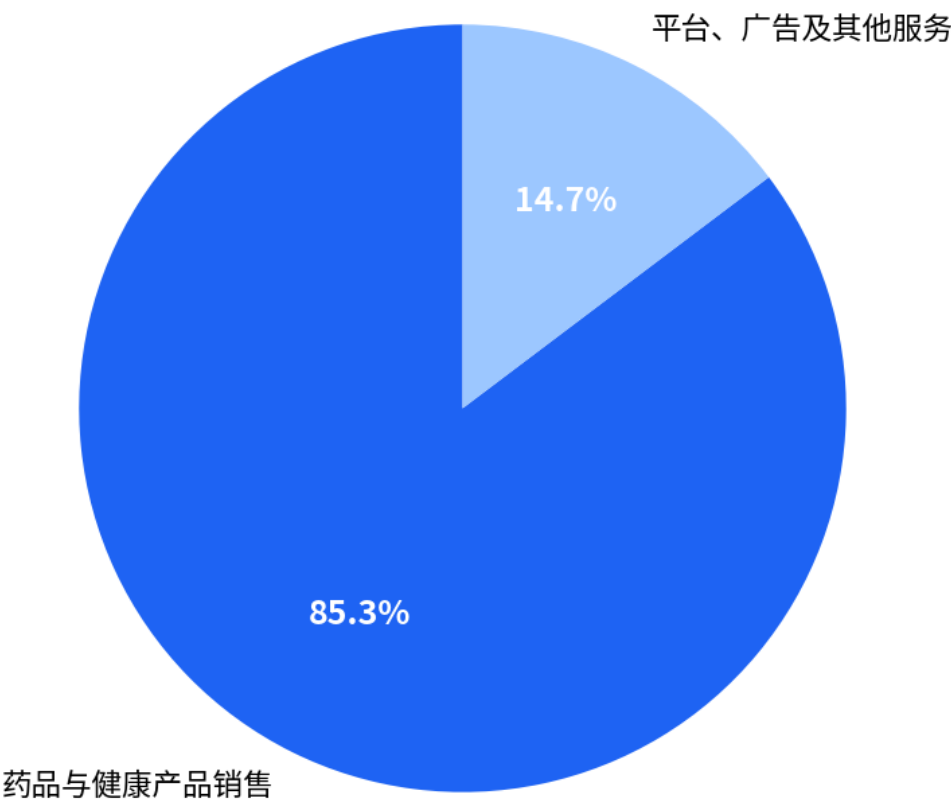


图 2：数字健康竞争定位示意。

京东健康是百度健康最重要的对标对象，但两者本质不同。京东健康 2023 年收入 535.30 亿元，其中药品与健康产品销售收入 456.53 亿元，平台、广告及其他服务收入 78.77 亿元；年活跃用户为 1.723 亿，2023 年平均日在线问诊量超过 45 万。[S4] 这说明京东健康的核心飞轮是：药品零售与供应链能力 → 高复购交易 → 在线医疗服务 → 线下延展 → 平台、广告和其他服务收入。

京东健康2023收入结构：交易与供应链占主导



总收入：535.30亿元；产品收入456.53亿元，服务收入78.77亿元

图 3：京东健康 2023 年收入结构

资料来源：京东健康 2023 年报

百度健康则更像：搜索与内容入口 → AI 意图识别与信息组织 → 医生/医院连接 → 患者流程工具与服务编排 → 可能的导流与服务收费。京东健康擅长强交易、强履约、强供应链；百度健康更应该强化入口、匹配、内容、AI 工具和开放生态。竞争策略不是复制，而是错位。

2.4 国际案例迁移：可学入口和工具，不宜照搬重资产交付

国际互联网公司进入健康业务，给百度健康的启发不是“完整复制某家公司”，而是拆出可迁移的模式。Apple Health 的启示在于把健康变成持续记录和提醒的用户入口；Microsoft/Nuance Dragon Copilot 的启示在于医生工作流 AI 工具更容易落地在低风险、高效率提升场景；Amazon One Medical 的启示在于问诊、药房、复诊、配送可以形成连续体验，但重资产医疗交付和会员制医疗在中国并不容易照搬；CVS 与 Google Cloud 合作推出 AI 驱动健康平台的逻辑，则更接近数据与 AI 基础设施层。^{[S5][S6][S7][S8]}

Apple Health：可迁移：持续健康入口、健康记录、提醒、用户日常互动；不可照搬：硬件闭环和海外监管许可体系；对百度启示：把一次性搜索变成长期健康账户。

Microsoft/Nuance：可迁移：自动病历、临床摘要、转诊信、医生文书辅助；不可照搬：直接进入高风险诊疗判断；对百度启示：优先做医生/医院工作流 AI 工具。

Amazon One Medical：可迁移：问诊、药房、复诊、续方、会员服务的一体化体验；不可照搬：重资产线下医疗和零售物流底座；对百度启示：交易闭环应合作优先，不宜自建全链路。

CVS/Google Cloud：可迁移：多源健康数据整合、实时健康管理平台；不可照搬：美国支付体系和药房网络不可直接移植；对百度启示：百度健康可与智能云、模型服务、机构系统结合。

第三部分：财务与经营

3.1 信息边界：百度健康没有独立财务报表

这是本报告最重要的真实性边界。百度 20-F 披露的是百度集团、Baidu General Business 和 iQIYI 等口径，而不是百度健康独立口径。公开资料没有给出百度健康独立收入、利润、成本、现金流、用户量、付费转化、GMV、合作医院数和医生数。因此，任何“百度健康收入多少、利润率多少”的精确数字，如果不能回溯到公司披露，都不应写成事实。

本文能做的，是站在百度集团财务框架下判断百度健康的资本约束、商业化方向和应避免的投入模式。不只是讲战略故事，而是看战略是否能转化为利润、现金流和资本效率。

3.2 百度集团财务约束：健康业务必须轻资产、可复用、可验证

百度 2025 年总收入为人民币 1290.79 亿元，较 2024 年下降 3%，主要原因是在线营销收入下降，云服务增长部分抵消了下滑。2025 年总成本和费用增至 1349 亿元，成本上升主要与云服务相关的带宽、折旧和服务器托管费用有关；2025 年确认长期资产减值 161.90 亿元，经营亏损 58.23 亿元，若剔除长期资产减值影响，经营利润为 104 亿元。^[S1]

现金流压力更值得关注。百度 2025 年经营活动现金流为净流出 30.13 亿元，而 2024 年为净流入 212.34 亿元；2025 年资本开支为 121 亿元，占收入 9%，主要用于服务器、网络设备和其他计算硬件，以支持网络基础设施容量和生成式 AI 研发投入。^[S1] 这说明百度健康如果要获得集团资源，必须证明它能够复用 AI 能力并形成高质量收入，而不能变成重仓储、重库存、重履约、重线下网点的资本消耗型业务。

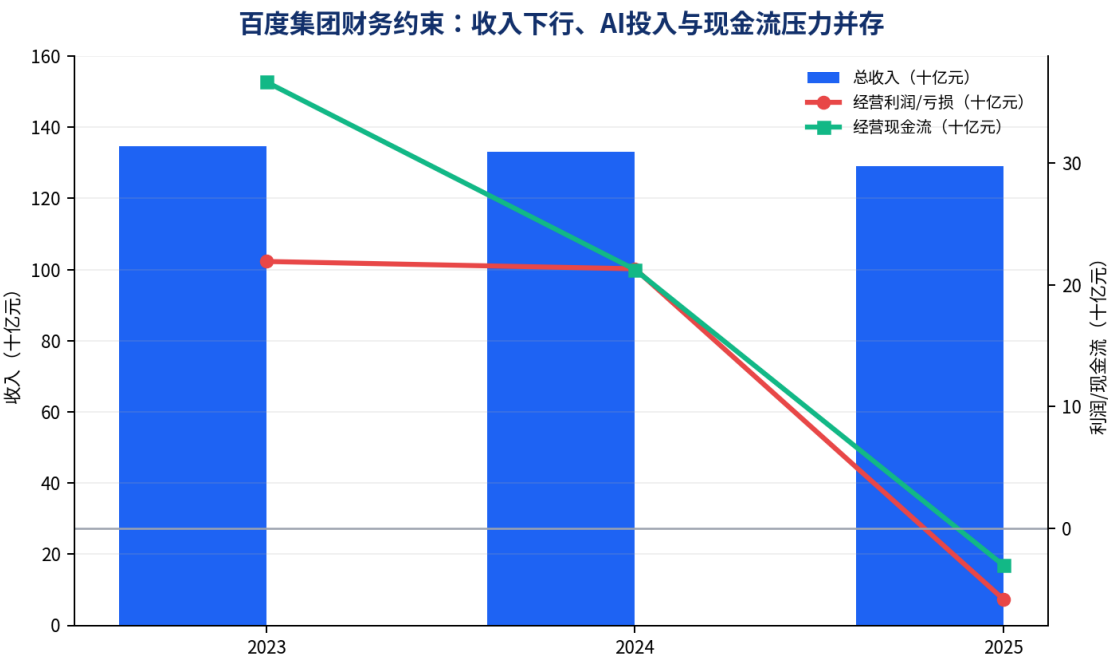


图 4：百度集团 2023-2025 财务走势

资料来源：百度 2025 Form 20-F

指标	2023	2024	2025
总收入（亿元）	1,345.98	1,331.25	1,290.79
经营利润/亏损（亿元）	219	213	-58.23
经营现金流（亿元）	366.15	212.34	-30.13
资本开支（亿元）	112	81	121
资本开支/收入	8%	6%	9%

3.3 与京东健康的财务对比：做大交易不等于适合百度

京东健康 2023 年收入达到 535.30 亿元，毛利 118.65 亿元，毛利率 22.2%，净利润 21 亿元左右。它的大头收入来自药品与健康产品销售，这验证了“医药电商 + 供应链 + 在线医疗服务”的规模化能力。^[S4]但这并不意味着百度健康应该复制。

原因在于能力禀赋不同。京东健康的履约费用在 2023 年达到 53 亿元，占收入 9.9%，这类费用与物流、仓储、订单履约高度相关。^[S4]如果百度重新搭建类似体系，需要面对库存、供应链、履约质量、药品监管和低毛利交易的长期成本。百度更合理的财务路径，是优先追求平台服务费、营销科技费、机构工具费、SaaS/AI 工具费和高意图线索收入。

维度	京东健康模型	百度健康更优路径
收入核心	药品与健康产品销售为主	健康搜索、服务编排、机构工具、AI 服务
资产特征	交易、供应链、仓配、履约更重	入口、AI、工具、合作网络更轻
主要成本	履约、仓储、物流、客户服务	模型调用、内容治理、机构运营、合规审核
风险重点	库存与履约质量、药品监管	医疗 AI 责任边界、内容可信、数据安全
百度是否应复制	不建议正面复制	应错位竞争，做高意图平台与工具层

3.4 经营与内控：百度健康真正要补的是医疗级质量治理

百度健康不是普通内容频道。只要平台对用户的就医行为产生影响，就必须建立接近医疗级别的质量控制体系。京东健康年报披露，其医疗服务质量控制体系包括医疗质量管理委员会和三级质量控制系统，并在 2023 年底发布 223 项诊疗标准和 12 项医疗质量与安全管理制度。^[S4]这给百度健康一个重要启示：即使百度健康不直接成为医疗主体，也需要建立内容、导诊、问答、服务转介和机构合作的全链路内控。

在百度场景下，内控重点至少包括五类：医学内容源分级、AI 回答边界控制、广告与自然结果强隔离、复杂问题人工升级、全链路留痕与审计。尤其在 AI 搜索结果大量进入移动搜索页后，健康场景必须比普通搜索更严格，因为错误建议、误导性导流和商业化过度都会直接损害信任。

第四部分：风险与战略

4.1 综合判断：百度健康应成为健康服务操作系统，而不是医药电商复制品

如果把前面的分析收束成一句话，本文对百度健康的判断是：百度健康最值得做的不是“中国另一个京东健康”，而是“中国 AI 时代的健康搜索与健康服务操作系统”。它的优势是用户健康意图入口、AI 意图识别、知识图谱、开放平台和医生/医院连接能力；它的短板是独立财务披露不足、医疗级信任机制仍需证明、线下履约和药品供应链能力弱于京东。

因此，百度健康不应该先追求 GMV 式扩张，而应该先验证三个指标：高质量健康搜索转化率、机构工具续费率、患者服务流程留存率。只有这些指标成立，百度健康才具备从内容频道走向服务平台的基础。

4.2 战略优先级：先可信入口，再流程编排，再机构工具

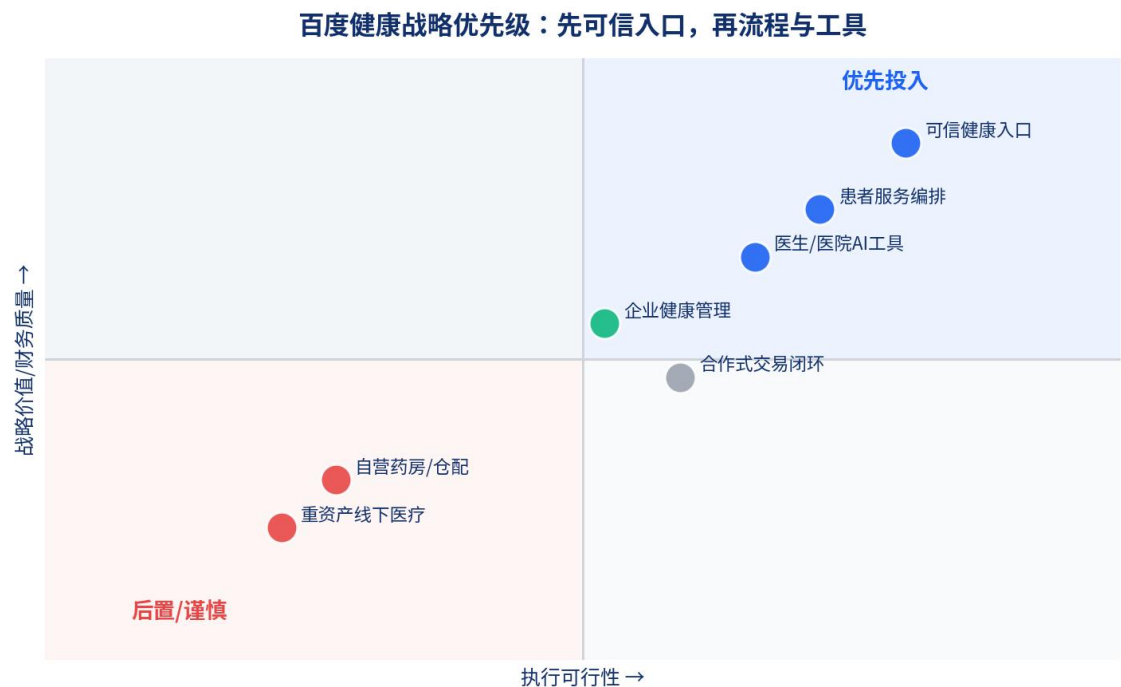


图 5：百度健康战略优先级矩阵

第一优先级：可信健康入口：建立医学内容源分级、AI 回答边界、广告/自然结果强隔离、复杂问题人工升级、全链路留痕审计。目标是把“信任”做成产品能力。

第二优先级：患者服务编排层：把搜索结果页升级为结构化下一步行动建议，覆盖预问诊、分诊导诊、预约挂号、复诊准备、慢病随访和院后管理。

第三优先级：医生/医院 AI 工具平台：提供医生主页托管、患者关系管理、内容运营、随访工具、AI 客服分流和辅助文书生成。优先进入低风险、高效率提升的工作流。

第四优先级：合作式交易闭环：与持牌医疗机构、药房、体检中心、保险或支付平台合作，不建议一开始自建药品仓配或线下医疗网络。

4.3 风险清单：医疗 AI 风险不是普通互联网产品风险

风险	为何重要	风险等级
监管与牌照风险	互联网诊疗、互联网医院、药品信息服务、数据安全等监管要求决定平台边界。	高
医疗 AI 责任边界	AI 预问诊和导诊若被用户理解为诊断，会带来责任与合规风险。	高
内容可信与商业化冲突	健康场景中广告、自然结果和 AI 生成内容边界若不清，会损害信任。	高
数据安全与隐私	健康数据敏感程度高，平台需防范个人信息、医疗信息、跨机构数据共享风险。	高
医生/医院供给不足	没有足够优质医疗资源，入口优势无法转化为服务闭环。	中高
用户支付意愿不足	消费者端健康助手和慢病服务若缺乏支付方或医保/保险协同，商业化可能慢。	中
集团资源约束	百度集团处于 AI 转型和现金流压力期，健康业务必须证明投入产出。	中高

4.4 跟踪指标：下一轮研究要补什么

- 百度健康是否有可公开验证的互联网医院牌照合作网络
- 合作医院/医生/机构客户数、机构工具产品页和商业化套餐
- 百度健康在百度 App 内的真实用户路径和产品截图
- 百度健康是否将 ERNIE/智能体能力嵌入预问诊、导诊、随访或机构工作台
- 健康搜索到预约/问诊/随访的转化率，若无公开数据则只能做访谈或产品实测
- 与京东健康、阿里健康、平安健康的最新年报口径对比

4.5 最终结论

百度健康的机会真实存在，但它不是一个可以靠想象堆数字的业务。公开资料能够支持的结论是：百度健康处在百度移动生态和 AI 搜索转型的交汇处，拥有高意图入口和 AI 组织能力；中国政策正在鼓励智能预问诊、分诊导诊、智能随访、慢病管理和患者服务流程；京东健康已经证明医药电商可以做大，但其供应链和履约能力不是百度天然优势。因此，百度健康的最优路径不是复制京东健康，而是围绕可信入口、服务编排、机构工具和合作式交易闭环，做轻资产、高信任、高可复用的健康服务操作系统。

附录：来源清单与核验说明

编号	来源	用途	链接
S1	Baidu, Inc. 2025 Form 20-F	百度集团财务、百度 App MAU、百度健康官方定位、AI 搜索、监管边界	https://ir.baidu.com/static-files/cd96c440-1fbc-4346-9d47-4248b2ef77c0
S2	国家卫健委：2024 年我国卫生健康事业发展统计公报新闻解读稿	卫生总费用、诊疗人次、65 岁以上老人健康管理人数	https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100132/202512/9db8db5488a748c4b1e1068a4a8c4455.shtml
S3	国家卫健委等：关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见	AI 医疗政策目标、预问诊、分诊导诊、随访、慢病管理、智能转诊	https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202511/d1a42ac835c743b9b3e83ac0253c3e9f.shtml
S4	JD Health International Inc. 2023 Annual Report	京东健康收入结构、在线问诊量、质量管理体系、服务能力	https://manager.wisdomir.com/files/586/2024/0426/20240426164501_60263610_en.pdf
S5	Reuters: Apple blood oxygen feature update	Apple Health/Apple Watch 健康能力案例	https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/apple-bring-blood-oxygen-feature-some-us-watches-with-software-update-2025-08-14/
S6	The Verge: Microsoft Dragon Copilot	医生工作流 AI 工具、临床文书、摘要、转诊信案例	https://www.theverge.com/news/622528/microsoft-dragon-copilot-ai-healthcare-assistant
S7	Amazon One Medical / Amazon Clinic public materials	Amazon Clinic 并入 One Medical、pay-per-visit telehealth 模式	https://clinic.amazon.com/
S8	Reuters: CVS taps Google Cloud to roll out AI-powered health platform	CVS/Google Cloud 健康数据与 AI 平台案例	https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cvs-taps-google-cloud-roll-out-ai-powered-health-platform-2026-03-05/